# Definição

Sintetizar o que a imersão descobriu e decidir o que o produto precisa resolver primeiro: o MVP

# Da imersão ao MVP: quatro ferramentas da Definição

✓ Briefing | ✓ Imersão | **Definição** | Ideação | Prototipação | Validação

*Etapa atual*

**1**

## Persona

Quem é a usuária-chave do produto

**2**

## Mapa de empatia

Como ela vive a consulta e o registro do exame do pé

**3**

## Canvas de proposta de valor

Quais dores o produto alivia e quais ganhos gera

**4**

## MoSCoW

Quais funcionalidades entram no MVP

**MVP (mínimo produto viável):** a primeira versão do produto, que atende às necessidades mínimas da usuária e permite testar se a solução funciona antes de investir no produto completo.

# Persona: Camila Andrade, a usuária-chave

## Camila Andrade



**IDADE**
29 anos

**PROFISSÃO**
Enfermeira da Estratégia Saúde da Família

**EDUCAÇÃO**
Graduação em Enfermagem; especialização em Saúde da Família em andamento

**ONDE TRABALHA**
UBS de pequeno porte, uma equipe de ESF, área com parte rural

**EXPERIÊNCIA**
2 anos na APS; usa o PEC todos os dias

**PERSONALIDADE**
Cuidadosa e prática. Se preocupa com o paciente além da consulta e faz visita domiciliar quando o ACS avisa. Quando falta material, improvisa para não deixar de avaliar. Quer fazer o exame do jeito certo, não só cumprir o indicador.

> *Quais dos meus diabéticos estão sem avaliação dos pés este ano? E quem tem o pé de risco?*
>
> *Eu preciso fazer a classificação, não só marcar qualquer coisa no PEC.*
>
> *Não pode ser muito grande. A gente não tem muito tempo na unidade.*

**CONTEXTO**
É ela quem faz o exame dos pés na UBS e aciona o médico quando o caso já está grave. A consulta de diabetes é cheia: pressão, glicemia, hemoglobina glicada, alimentação e, por último, os pés. A UBS não tem monofilamento nem diapasão. Preenche a ficha de papel, que vai para a pasta dos diabéticos, e depois escreve a mesma avaliação no PEC, em texto livre, e lança o código do exame do pé.

# Persona: o que a Camila busca e o que a frustra

### DESEJOS, NECESSIDADES E MOTIVAÇÕES

- Fazer uma avaliação completa e padronizada, mesmo sem monofilamento e diapasão.
- Registrar uma vez só, direto no PEC.
- Saber o risco de cada paciente e quando ele deve voltar.
- Ver quem está atrasado ou com risco alto sem depender só do ACS.
- Evitar amputações que poderiam ser prevenidas.

### DORES E FRUSTRAÇÕES

- Improvisa o teste de sensibilidade (com fio dental) por falta de instrumento.
- Anota tudo duas vezes: no papel e no PEC, em texto livre de 250 caracteres por perna.
- Para ver a avaliação anterior, abre o prontuário consulta por consulta.
- O PEC mostra se o código foi lançado, mas não mostra o risco.
- Já viu um pé grave chegar tarde demais e terminar em amputação.

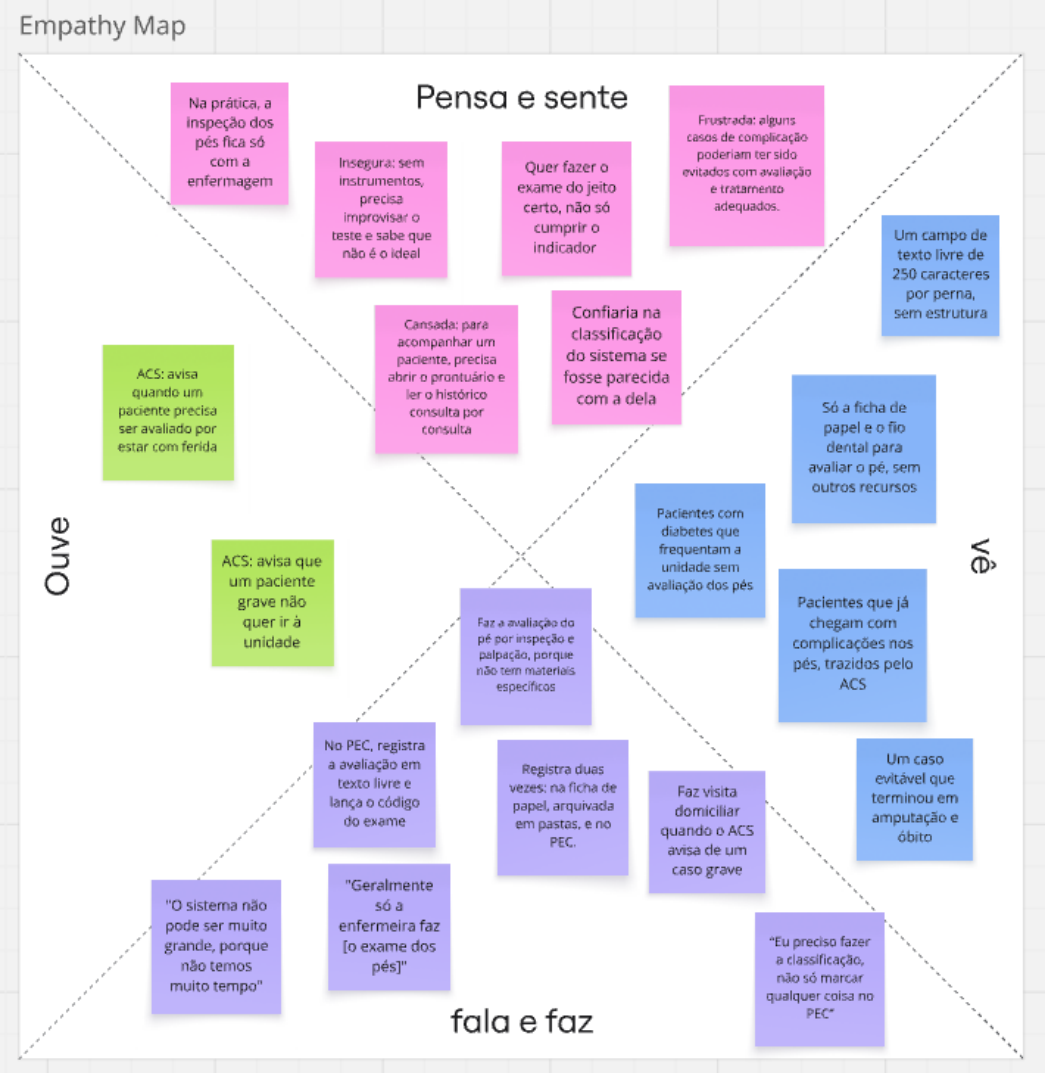
### FATORES IMPORTANTES

Domina o PEC e aceita uma ferramenta nova se ela for curta e couber na consulta. Confia numa classificação automática quando ela coincide com o seu julgamento clínico: quer decidir, não só clicar. O registro dela pontua na boa prática F do indicador C4.

# Cada elemento da persona tem fonte na imersão

| Elemento da persona | Evidência | Fonte |
|---|---|---|
| Enfermeira da ESF, 2 anos de APS | Entrevistada formada há 2 anos, 1 ano na APS | Entrevista, P1 |
| UBS pequena com área rural, sem monofilamento e diapasão | UBS rural; só tinha a ficha de papel e fio dental | Entrevista, P1 e P4; CSD (certeza) |
| É ela quem faz o exame; aciona o médico nos casos graves | "Geralmente só a enfermeira faz" | Entrevista, P3 |
| Consulta cheia, pouco tempo | PA, CA, glicemia, HbA1c, alimentação; "não temos muito tempo" | Entrevista, P5 e P14; CSD (suposição) |
| Registro duplo, texto livre de 250 caracteres | Ficha em pastas por grupo, mais texto corrido no PEC | Entrevista, P6 e P7; benchmarking |
| Abre o prontuário consulta por consulta | Filtro mostra só o código, não os achados | Entrevista, P8 e P10; benchmarking |
| Depende do ACS para achar quem está atrasado | "Não dependeríamos só da visita mensal do ACS" | Entrevista, P10 e P12 |
| Quer classificar, não só clicar | Confiaria se o risco coincidisse com o dela | Entrevista, P13; CSD (suposição) |
| Quer formulário curto dentro do PEC | "Simples e pequeno, mas que permita avaliação adequada" | Entrevista, P12 e P14 |
| Já viu caso terminar em amputação | Necrose → vascular → amputação → óbito | Entrevista, P11 |
| Registro conta para a boa prática F | Enfermeiro está no Quadro 07 da Nota C4 | Nota Metodológica C4; CSD (certeza) |

# Mapa de empatia: a consulta, na hora do exame do pé




## O que o mapa mostra

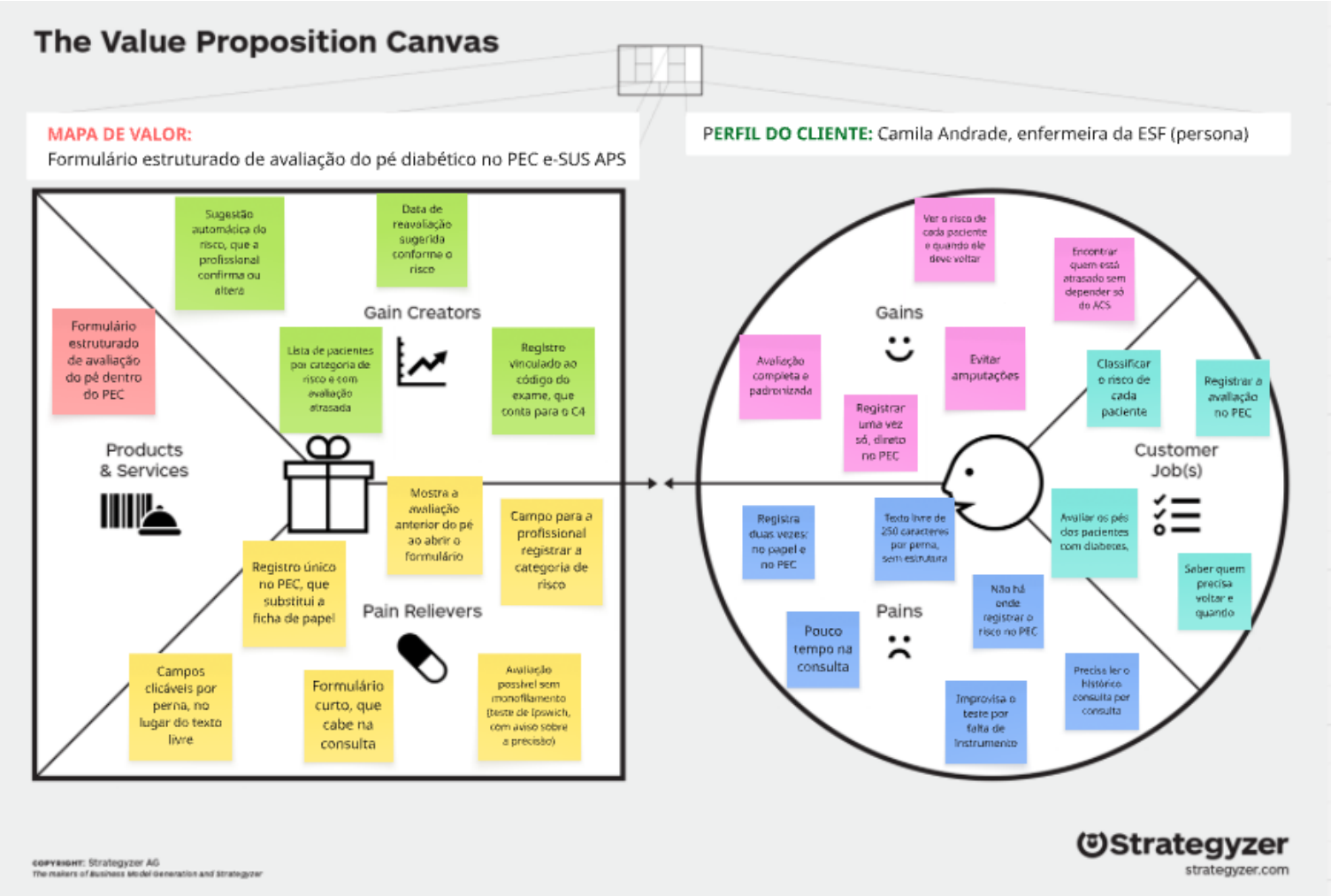
**Pensa e sente** Insegura por improvisar o teste, frustrada com casos evitáveis; confiaria no sistema se o risco coincidisse com o dela.

**Vê** Texto livre de 250 caracteres, ficha de papel e fio dental, e pacientes que chegam com complicações.

**Ouve** Os avisos do ACS sobre pacientes com ferida ou que não querem ir à unidade.

**Fala e faz** Registra duas vezes e lança só o código. "Preciso fazer a classificação, não só marcar qualquer coisa no PEC."

# Canvas de proposta de valor: cada dor tem um analgésico




## O encaixe

| | |
|---|---|
| Texto livre de 250 caracteres | Campos clicáveis por perna |
| Registra duas vezes | Registro único no PEC |
| Não há onde registrar o risco | Campo para a categoria de risco |
| Pouco tempo na consulta | Formulário curto |
| Improvisa o teste | Avaliação sem monofilamento |

**Dores** → **analgésicos**: os analgésicos são candidatos a Must have; os criadores de ganho, a Should e Could have.

# O achado que orientou o MVP: a profissional quer decidir

> *Primeiro eu faria a minha avaliação. [...] Se a classificação do sistema fosse parecida com a minha, eu confiaria. Mas eu preciso fazer a classificação, não só marcar qualquer coisa no PEC.*

Entrevista, pergunta 13: "Se o sistema sugerisse o risco, você confiaria nele ou preferiria decidir?"

**O que indica**
A dor principal é o registro: hoje não existe onde registrar o risco no PEC, só o código do exame.

**O que muda**
A classificação automática não substitui a profissional: o sistema sugere e mostra o motivo; ela confirma ou altera.

**Por que manter no MVP**
Com os campos estruturados, o cálculo IWGDF é uma regra fixa e custa pouco. É o diferencial do projeto.

**Limite:** é uma única entrevista, com uma integrante do grupo. A decisão é uma suposição reforçada, a ser validada com outras profissionais na etapa de validação.

# MoSCoW: as funcionalidades priorizadas

## Must have
O MVP

**Formulário estruturado do exame do pé**
Campos clicáveis por pé no lugar do texto livre; registra o teste usado

**Classificação de risco sugerida**
Categoria IWGDF (0 a 3) e o motivo

**Confirmação pela profissional**
Ela confirma ou altera; a categoria final fica no PEC

**Código SIGTAP automático**
Só com avaliação completa e por profissional do Quadro 07 (C4)

## Should have
Próxima versão

**Data de retorno sugerida**
Conforme o risco (PCDT DM2)

**Avaliação anterior visível**
E dados que o PEC já tem

**Alerta de urgência**
Úlcera ativa, infecção, isquemia, Charcot

**Teste de Ipswich**
Alternativa sem monofilamento, com aviso

## Could have
Desejável

**Lista de pacientes**
Por risco e com avaliação atrasada

**Agendamento do retorno**
Direto na agenda do PEC

**Dados agregados**
Para a gestão

**Orientações de autocuidado**
Para imprimir e entregar

## Won't have
Por enquanto

**App separado**
Fora do PEC ou para o paciente

**Tablet ou visita domiciliar**
Uso fora da UBS

**IA por foto**
Análise de fotos dos pés

**LEDI e sistemas próprios**
Layout e-SUS de Dados e Interface

# O MVP na consulta: do exame ao C4 em quatro passos

1

## A profissional registra

Achados por pé em campos clicáveis: pele, vascular e sensibilidade

2

## O sistema sugere

Categoria de risco IWGDF e o motivo (ex.: risco 2: perda de sensibilidade + deformidade)

3

## A profissional decide

Confirma ou altera a categoria; a categoria final fica no PEC

4

## O PEC lança o código

SIGTAP 03.01.04.009-5, só com avaliação completa e por profissional autorizado

**Para a profissional**
Um registro só, estruturado, com o risco que ela validou

**Para o cuidado**
O risco fica visível no PEC, e não no papel ou na memória

**Para a gestão**
A boa prática F do C4 passa a refletir um exame completo, não só o código

# Referências da Definição


BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Nota metodológica C4: cuidado da pessoa com diabetes. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Portaria SCTIE/MS nº 13, de 21 de fevereiro de 2026. Atualiza o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 2. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026b.

ENTREVISTA concedida ao grupo por usuária do PEC e-SUS APS. 2026.

INTERNATIONAL WORKING GROUP ON THE DIABETIC FOOT. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease. [S. l.]: IWGDF, 2023.

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y.; BERNARDA, G.; SMITH, A. Value Proposition Design: how to create products and services customers want. Hoboken: Wiley, 2014.

SACCO, I. C. N. et al. Diagnóstico e prevenção de úlceras no pé diabético. Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2026. DOI: 10.29327/5412848.2024-11.